

美国的医疗体系(US Health System)在全球范围内非常独特, 它既不是像英国、加拿大那样的“国家单方支付/全民免费医疗体系”, 也没有统一的全国统一定价。

美国医疗体系是一个由私营市场为主导、政府公共计划为补充的混合体系。

一、医疗保险的四大来源

在美国, 医疗费用极其昂贵, 没有保险极难负担。大多数人通过以下途径获取保险:

- 雇主提倡保险 (**Employer-Sponsored Insurance**): 覆盖约50%的人口。绝大多数在职人员由公司购买团购保险, 公司支付大部分保费, 个人按月缴纳剩余部分。
-
- **Medicare**(联邦医疗照顾计划): 针对 **65岁**及以上老者 以及部分残疾人士的联邦公共保险。
-
- **Medicaid**(州及联邦医疗补助计划): 针对 低收入群体、贫困家庭及特定残障人群 的公共资助计划, 由联邦和州政府共同出资管理。
-
- **Obamacare / Marketplace**(奥巴马医改个人交易市场): 适合自由职业者或没有雇主保险的人群, 政府根据家庭收入提供保费补贴。

二、医疗服务提供方与网络机制

美国的医院、诊所和医生绝大多数是私营的。保险公司与医疗机构通过医疗网络(Network)进行合作:

- **Network In**(网内医生/医院): 保险公司与该医疗机构签署了折扣协议, 报销比例高, 个人自付少。
-
- **Network Out**(网外医生/医院): 未签署协议, 保险公司报销极少甚至完全不报销, 个人需承担极高费用。
-

常见的保险计划类型包括:

- **HMO**: 保费便宜, 但必须选择一名主治医生(PCP), 看专科医生必须先由主治医生转诊(Referral), 且只报销网内医疗费用。
-
- **PPO**: 保费较贵, 但自由度高, 无需转诊即可看专科, 网外医疗也可获得部分报销。
-

三、核心费用概念(如何算账)

看病时, 患者除了每月固定缴纳的保费(Premium)外, 通常需要承担以下费用:

费用名称	概念解释
Deductible (自付额)	每年自费达到该额度前, 保险公司不赔付(预防性体检等除外)。
Copay (定额共付)	每次看病或拿药时支付的固定金额(如诊所挂号费\$20)。
Coinsurance (按比例共付)	达到自付额(Deductible)后, 与保险公司按比例分摊费用(如保险付80%, 个人付20%)。
Out-of-Pocket Maximum (年度自付上限)	个人一年内自付费用的上限金额, 一旦达到此金额, 后续合格医疗费用100%由保险覆盖。
